



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Página 1/8	
Título do Documento	MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E ISOLAMENTOS	Emissão: 31/05/2026 Versão: 4	Próxima revisão: 31/05/2027

1. CONCEITO: Prevenção a transmissão de microrganismos de um paciente, portador e ou doente, para outro, tanto de forma direta como indireta.

1.1 Responsável
SCIRAS

1.2 Responsáveis pela execução
É de responsabilidade de todos da equipe assistencial, incluindo os profissionais da equipe multidisciplinar.

1.3 Finalidades

- Promover medidas de precaução e isolamentos;
- Evitar transmissão cruzada de microrganismos;
- Evitar transmissão de microrganismos para o profissional de saúde;
- Evitar deterioração clínica do paciente;
- Promover maior rotatividade de leitos;

2. MATERIAIS

- EPI's
- Placas de precaução padronizadas pela Anvisa
- Pastas plásticas pretas para capa de prontuário
- Plaquinhas sinalizadoras de precaução para identificação do prontuário

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Página 2/8	
Título do Documento	MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E ISOLAMENTOS	Emissão: 31/05/2026	Próxima revisão: 31/05/2027
		Versão: 4	

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

PRECAUÇÃO PADRÃO

A Precaução padrão deve ser adotada no contato com todos os pacientes, independente da patologia ou condição clínica;

Higienizar as mãos com água e sabonete ou friccionar preparação alcóolica nos 5 momentos da higiene das mãos;

Higienizar as mãos antes de calçar as luvas e após retirá-las;

Utilizar luvas sempre que houver algum risco de contato com secreções, fluidos corporais, pele não íntegra e mucosas (o uso de luvas não substitui a higiene das mãos);

Usar máscaras, óculos e protetor facial em procedimentos que possam gerar respingos nas mucosas ocular, nasal e oral;

Utilizar avental quando houver risco de contaminação da roupa por fluídos corporais;

Ao retirar o avental, descarta-lo no local de atendimento do paciente. Higienizar as mãos após;

Não utilizar EPI fora da área de assistência;

Trocar avental e luvas a cada paciente atendido.

Identificar os resíduos de serviços de saúde do Grupo A pelo símbolo de risco biológico, com rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da expressão RESÍDUO INFECTANTE;

Descartar em lixeira de resíduo infectante os resíduos provenientes de pacientes em precaução por contato/gotícula/aerossóis;

Descartar fluidos corporais no expurgo adotando as medidas de precaução padrão e com cuidado para não causar “respingos”.

Não retirar agulhas usadas das seringas descartáveis, não dobrá-las e nunca reencapá-las utilizando as duas mãos. O descarte desses materiais deve ser feito em caixas apropriadas e resistentes. Sempre respeitar o limite de 2/3 da capacidade de enchimento destes recipientes.

PRECAUÇÃO POR CONTATO

Sinalizar a porta do quarto com placa de precaução de contato e realizar a identificação no prontuário.

Internar o paciente em quarto privativo. Quando não for possível, realizar isolamento por coorte em um quarto com paciente que apresente infecção pelo mesmo microorganismo e mesma resistência antimicrobiana, respeitando a distância de 1 metro entre os leitos.

Utilizar luvas e avental de manga longa descartáveis exclusivos para o atendimento ao paciente: usá-los no contato com o paciente, manipulação de cateteres e sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito;
Colocar as luvas e o avental imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies próximas a ele, dentro do quarto do paciente.
Retirar as luvas e o avental , logo após o uso, antes de deixar o quarto. Higienizando as mãos em seguida;
Descartar os EPIs em lixeira adequada ainda dentro do quarto/enfermaria do paciente;
Artigos e equipamentos devem ser de uso exclusivo do paciente;
Após o uso de artigos e equipamentos, limpá-los e desinfetá-los/esterilizá-los após cada uso e alta/transferência;
Para equipamentos não-críticos, quando não houver quantitativo para uso exclusivo, proceder com desinfecção a cada uso. Ex.: termômetro, glicosímetro;
O transporte do paciente deve ser evitado, porém, quando necessário, o profissional deverá usar luvas e avental descartáveis para o contato com o paciente, tendo cuidado em não tocar em superfícies com as mãos enluvasadas;
Macas e cadeiras utilizadas no transporte, e locais onde o paciente teve contato, deverão sofrer desinfecção após o uso, de preferência com álcool 70% ou de acordo com as especificações dos materiais.
Em caso de transporte do paciente, na necessidade de exames, procedimentos, o local de destino deve ser informado acerca da precaução.
Disponibilizar banheiro de uso exclusivo ou cadeira sanitária para pacientes colonizados/infectados por MDR;
PRECAUÇÃO POR AEROSSÓIS
Isolar paciente de caso suspeito ou confirmado de infecção por agente transmitido por aerossóis, partículas que ficam suspensas no ar e que são eliminadas pela fala, tosse, espirros de pessoas infectadas (ex.: tuberculose pulmonar ou laríngea, varicela, sarampo);
Sinalizar a porta do quarto com placa de precaução para aerossóis e realizar a identificação no prontuário;
Internar o paciente em quarto privativo. Quando não houver disponibilidade, interná-lo em quarto com paciente que apresente infecção pelo mesmo microorganismo. A distância mínima entre dois pacientes ou entre pacientes e visitantes deve ser de um metro.
Manter as portas do quarto sempre fechadas;
A máscara N95 ou PFF2 é de uso obrigatório pelo profissional durante todo o tempo em que estiver no quarto e deverá ser retirada apenas ao sair do quarto;
O transporte do paciente deve ser evitado, porém, quando necessário, ele deve utilizar imprescindivelmente, máscara cirúrgica.
PRECAUÇÃO POR GOTÍCULAS
Sinalizar a porta do quarto com placa de precaução para gotículas e realizar a identificação no prontuário.
Internar o paciente em quarto privativo. Quando não houver disponibilidade, interná-lo em quarto com paciente que apresente infecção pelo mesmo microorganismo. A distância mínima entre dois pacientes ou entre pacientes e visitantes deve ser de um metro.

A circulação de ar e ventilação especiais não são necessárias.

A máscara cirúrgica é de uso obrigatório para todas as pessoas que tiverem acesso ao quarto; e pelo profissional e paciente quando for transportado, bem como o acompanhante.

O transporte do paciente deverá ser evitado, porém, quando necessário, ele deve utilizar máscara cirúrgica.

SEQUENCIA CORRETA DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO DE EPI's

PARAMENTAÇÃO	DESPARAMENTAÇÃO
1. Higienizar as mãos	Retirar as luvas
2. Colocar avental ou capote (em procedimentos geradores de aerossóis, utilizar capote impermeável).	1. Higienizar as mãos
3. Colocar máscara cirúrgica ou N95 (a depender do tipo de precaução)	2. Retirar o avental tocando na parte interna
4. Colocar gorro, quando recomendado.	3. Retirar o gorro
5. Colocar óculos de proteção.	4. Retirar os óculos de proteção
6. Higienizar as mãos..	5. Higienizar as mãos
7. Calçar luvas.	6. Retirar a máscara
	7. Higienizar as mãos

MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

LIMPEZA CONCORRENTE

Realizar limpeza diária, três vezes ao dia e sempre que necessário nos quartos de pacientes colonizados/infectados por MDR;

realizar limpeza de todas as superfícies horizontais, de mobiliários e equipamentos, portas e maçanetas, parapeitos de janelas, piso, instalações sanitárias, cama, criado-mudo, painel de gases, painel de comunicação, suporte de soro, mesa de refeição e outros mobiliários que podem ser utilizados durante a assistência prestada;

Definir os tipos de saneantes utilizados de acordo com o tipo de microrganismo;

Esvaziar lixeiras

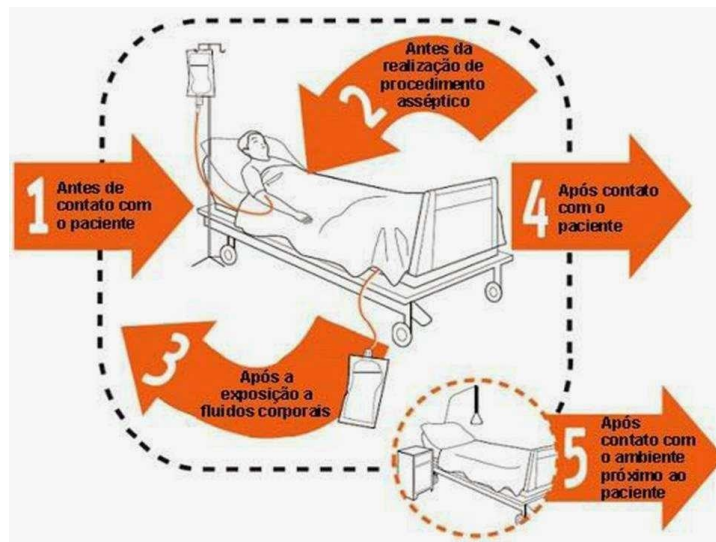
LIMPEZA TERMINAL

Realizar limpeza terminal a cada 15 dias e nas seguintes situações: alta hospitalar, transferências, óbitos e

ao suspender as precauções de contato, gotículas e aerossóis;
Definir os tipos de saneantes utilizados de acordo com o tipo de microrganismo;
Limpar, conforme POP institucional: paredes, pisos, teto, painel de gases, equipamentos, todos os mobiliários como camas, colchões, macas, mesas de cabeceira, mesas de refeição, armários, bancadas, janelas, vidros, portas, peitoris, divisórias, biombos, luminárias, lixeira, filtros e grades de ar-condicionado etc.
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS
Utilizar equipamentos (oxímetros, esfigmomanômetros, termômetros etc.) exclusivos para o cuidado do paciente em isolamento;
Realizar a limpeza e desinfecção entre os usos quando os equipamentos para o cuidado do paciente em isolamento não forem exclusivos (oxímetros, esfigmomanômetros, termômetros).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Página 6/8	
Título do Documento	MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E ISOLAMENTOS	Emissão: 31/05/2026	Próxima revisão: 31/05/2027
		Versão: 3	

4. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS



Precaução Padrão

Devem ser seguidas para TODOS OS PACIENTES, independente da suspeita ou não de infecções.



Higienização das mãos



Luvas e Avental



Óculos e Máscara



Caixa perfuro-cortante

- **Higienização das mãos:** lavar com água e sabão ou fricção as mãos com álcool a 70% se as mãos não estiverem visivelmente sujas antes e após o contato com qualquer paciente, após a remoção das luvas e após o contato com sangue ou secreções.
- Use luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.

- Use óculos, máscara e/ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais.
- Descarte, em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-las.

Precauções para Gotículas



Higienização das mãos



Máscara Cirúrgica (profissional)



Máscara Cirúrgica (paciente durante o transporte)



Quarto privativo

- **Indicações:** meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza, rubéola, etc.
- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo. A distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.

- O transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.

Precauções para Aerossóis



Higienização das mãos



Máscara PFF2 (N-95) (profissional)



Máscara Cirúrgica (paciente durante o transporte)



Quarto privativo

- **Precaução padrão:** higienize as mãos antes e após o contato com o paciente, use óculos, máscara cirúrgica e/ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções, descarte adequadamente os perfuro-cortantes.
- Mantenha a porta do quarto SEMPRE fechada e coloque a máscara antes de entrar no quarto.
- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros pacientes com infecção pelo mesmo microrganismo. Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose.
- O transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário o paciente deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.

Precaução de Contato



Higienização das mãos



Avental



Luvas



Quarto privativo

- **Indicações:** infecção ou colonização por microrganismo multiresistente, varicela, infecção de pele e lesões molares com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido, etc.
- Use luvas e avental durante toda manipulação do paciente, de cateteres e sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito. Coloque-as imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.
- Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio devem ser de uso exclusivo do paciente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Página 7/8	
Título do Documento	MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E ISOLAMENTOS	Emissão: 31/05/2026 Versão: 4	Próxima revisão: 31/05/2027

5. REFERÊNCIAS

- BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). Prevenção de infecções por microrganismos multirresistentes em serviços de saúde – Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2021. 103p. Disponível em: <https://pncq.org.br/wp-content/uploads/2021/03/manual-prevencao-de-multirresistentes7.pdf>. Acesso em: 01 de Julho de 2023.
- CAMPOS, A. P., SILVA, A. C. D. A., DUTRA, E. B. F., ROCHA, P. O., & FERNANDES, T. (2022). Impactos para o paciente da não adesão às medidas de precauções padrão e de isolamento no ambiente hospitalar. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/24717>. Acesso em: 01 de Julho de 2023.
- Faria, L. B. G. D., Santos, C. T. B. D., Faustino, A. M., Oliveira, L. M. D. A. C., & Cruz, K. C. T. D. (2019). Conhecimento e adesão do enfermeiro às precauções padrão em unidades críticas. *Texto & Contexto-Enfermagem*, 28. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/CyNfyfNJvgWCgKTGMkN6pwt/?lang=pt>. Acesso em: 01 de julho de 2023.
- Prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde: Precauções e isolamentos. Brasília-DF, 2025.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Página 8/8	
Título do Documento	MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E ISOLAMENTOS	Emissão: 31/05/2026	Próxima revisão: 31/05/2027
		Versão: 4	

7. HISTORICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSAO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
01	01/08/2023	Atualização e padronização
02	01/08/2024	Revisão
03	31/05/2025	Revisão
04	31/05/2026	Atualização

Versão 1 - Elaboração Nayanne Ingrid Farias Mota Guerra	Data: 01/07/2023
Versão 2 - Revisão Ana Carolina Gomes de Farias	01/07/2024
Versão 3 - Revisão Ana Carolina Gomes de Farias	31/05/2025
Versão 4 - Atualização Ana Carolina Gomes de Farias Julia Rodrigues Chaves	31/05/2026
Revisão Giulianna Carla Validação Matheus Soares Registro, análise e revisão final Giulianna Carla Matheus Soares Aprovação Matheus Soares Sonia Delgado	Data: 31/05/2026 31/05/2026